

الشريط الوسيط للإحليل هو الجراحة الأكثر شيوعاً لعلاج سلس البول الإجهادي (SUI) عند النساء — أي التسرب عند السعال أو الضحك أو الرفع أو التمرين. يُوضع شريط رفيع من الشبكة الاصطناعية تحت منتصف الإحليل (مجرى البول) ليدعمه فلا ينفث عند ارتفاع الضغط. العملية سريعة وتُجرى في الغالب دون إقامة بالمستشفى، وهي فعالة جداً وذات نتائج طويلة الأمد.

عن هذه العملية

من خلال شق صغير داخل المهبل، يُثبت شريط رفيع دون شدّ تحت منتصف الإحليل كالمرجوحة. عند السعال أو الضغط يضغط الإحليل على الشريط فيبقى مغلقاً. لا شيء تُشغله بنفسك بعد ذلك — يعمل تلقائياً. تتوفر مسارات مختلفة (خلف العانة أو عبر السدادة) وأشرطة مُصغرة أحادية الشق؛ يختار جراحك المناسب لك.

عن الشبكة الاصطناعية

الشريط الوسيط للإحليل من أكثر العمليات في صحّة المرأة دراسةً وثيقاً، وله سلامة ونجاح مؤكّدان على المدى البعيد. وهو مختلف عن الشبكة المهبليّة المستخدمة لهبوط الأعضاء التي صدرت بحقّها تحذيرات FDA. إذا كنتِ تفضّلين تجنّب الشبكة الاصطناعية، فالشريط المصنوع من نسيجك الخاص (الشريط اللفافي الذاتي) هو البديل.

تعلم المصطلحات

سلس البول الإجهادي

تسرب البول عند الضغط كالسعال والضحك والرفع.

الشريط الوسيط للإحليل

شريط شبكي يدعم منتصف الإحليل (مجرى البول).

دون شدّ

يستقرّ الشريط تحت الإحليل دون أن يضغط عليه.

خلف العانة / عبر السدادة

مساران لتمرير الشريط؛ كلاهما فعال.

الشريط الذاتي

شريط مصنوع من نسيج المريضة بدلاً من الشبكة الاصطناعية.

انكشاف الشبكة

مشكلة غير شائعة تظهر فيها جزء من الشبكة؛ قابلة للعلاج.

هل سيؤلم؟ تُجرى العملية تحت التخدير (العام أو الشوكي) فلا تشعرين بشيء أثناءها، وتستغرق في الغالب أقل من 30 دقيقة. تعودين للمنزل في نفس اليوم مع ألم خفيف وتستأنفين الأنشطة الخفيفة سريعاً.

كيف تستعدين

بعد العملية

- الألم الخفيف والنزيف اليسير طبيعيان.
- تجنّبي الرفع الثقيل والإجهاد والجماع لمدة 6 أسابيع تقريباً.
- قد تحتاجين أحياناً إلى قسطرة قصيرة المدة إذا كان التبول بطيئاً في البداية.

- اتّبعي تعليمات التخدير (الصيام وإيقاف مميّعات الدم حسب التوجيهات).
- تحليل البول للتأكد من خلوه من العدوى؛ وأحياناً اختبار وظائف المثانة مسبقاً.
- رتّبي من يوصلك؛ خطّطي للراحة من الأعمال الشاقة لأسبوعين تقريباً.

ما الذي يحدث

اتصلي بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عدم القدرة على التبول أو الشعور بعدم الإفراغ الكامل
- حمّى أو نزيف غزير
- ألم متزايد، أو ألم لاحق أثناء الجماع، أو إفرازات مهبلية (احتمال مشكلة في الشبكة)

1 تكوينين تحت التخدير؛ تُعطى المضادات الحيوية.

2 يُجرى شقّ مهبلي صغير ويُوضع الشريط دون شدّ تحت منتصف الإحليل.

3 نقاط الخروج الصغيرة (فوق العانة أو في الأربية) تلتئم من تلقاء نفسها؛ يُغلق الشقّ المهبلي.

4 تتبولين عادةً قبل المغادرة للتأكد من إفراغ المثانة بشكل كافٍ.

ثلاثة أمور تذكّريها

1. الشريط الوسطي للإحليل يدعم الإحليل لوقف التسرّب الإجهادي — سريع وخارجي وفعال جداً دون الحاجة لتشغيله.
2. شبكته مدروسة وأمنة وتختلف عن شبكة هبوط الأعضاء المسحوبة؛ والشريط الذاتي متاح إن كنت تفضّلينه.
3. تجنّبي الرفع الثقيل والجماع نحو 6 أسابيع. اتصلي إذا تعرّدت التبول، أو ظهرت حمّى، أو ألم/إفرازات لاحقاً.